匯聚交流：展開心理健康城市在地行動

1. 全人全齡全家全社區心理健康支持
2. 不利處境群體之心理健康人權實踐
3. **預防與促進並重之心理健康策略**

吳肖琪
亞洲大學講座教授、陽明交通大學退休特聘教授
社團法人台灣長期照護專業學會 常務理事

2026年10月2日（五）14:00-14:15、14:15-15:30
立法院群賢樓9樓、台大校友會館5樓會議室

參考資料

2013年衛生福利部成立時設置「心理及口腔健康司」，將「精神醫療」擴大為「心理健康」

- 吳肖琪、鄭若瑟(2011)：「國民心理健康促進計畫建議書」，衛生署委託
  - 確立心理健康的重要性
  - 以三維架構（三段五級、目標人口群、政策發展面向）探討心理健康議題
  - 確認各部會之內部顧客以推動心理健康業務，建議心理健康之績效指標
- 吳肖琪、鄭若瑟(2013)：「建構心理健康網規劃計畫建議書」，衛福部委託
  - 未來四年「心理健康網」應達成哪些近程目標？該透過那些策略以順利推動網絡？

何謂「心理健康促進」？

– ***提升心理幸福感、增強心理承受能力和應變能力，創造良好的生存條件和環境，以促進民眾正向的心理健康***

- 目標(Sainsbury, Peter, 2003; WHO, 2004; Hunter Institute of Mental Health, 2010; Nelson, Geoffrey, 2010)
  - 提昇**心理健康與幸福**的**積極行動**，而非僅聚焦於減少問題
  - 藉由**活動或方案的介入**，促進社會、情緒、心靈的安適程度與生活品質
- 特性(Cowen, Emory L. , 1996; WHO, 2004)
  - 具有**前瞻性**或**積極主動性**(proactive)，可提昇心理健康程度
  - 聚焦於**群體的介入**，而非個人層次
  - 為**多面向的整合系統架構**(含個人、家庭、環境、社區脈絡及巨觀層面的社會結構及政策)
  - **持續不斷的發展**，非一次性或有時間限制的介入方式
- 積極內涵(Sainsbury & Peter, 2003)
  - 包括**快樂**、**主觀幸福感**、**心理安適**、**生活滿意**與**生活品質**

心理健康與幸福感 (mental health and well-being)

- Hunter Institute of Mental Health 於2010年提出 ‘ POWER ’ 以解釋心理健康與幸福感之意涵
  - **正向**(Positive)、幸福
  - **樂觀**(Optimistic)、適應
  - **全人**(Wholistic)、生活整體、文化決定
  - **享受生活**(Enjoyment of life)、連繫感、歸屬感
  - **韌性、復原力**(Resilience)、可隨機應變的(Resourcefulness)



由‘POWER’延伸為’EMPOWER’

泰國之幸福策略

- 「幸福八要素」
  - **生活安全**(如房屋、土地、吃飯、金錢、水稻)
  - **物理和精神力量**(如健康、長壽、無個人疾病)
  - **溫馨的家庭**(住在一起、無爭吵、勤奮的孩子、生活品質)
  - **強化社區**(如持續學習、參與、支持強度)
  - **良好的環境**(如土壤、水、森林、航空、路、電力、宜居環境)
  - **自由**(如依自我期待做事、無債務、思想自由、獨立就業)
  - **自尊**(如素養、成功、成長、教育他人)
  - **與佛法共存**(如贈與、為自己所擁有的感到滿足、開心的生活在一起、學習佛法)

- 「十項幸福宣言」
  - 以**運動**提升生理功能
  - **思考**幸福的來源
  - 慢慢**商量**
  - **種植**植物
  - **減半看電視的時間**
  - **微笑**/向陌生人**打招呼**
  - 手機朋友(phone friend)
  - 有個很棒的**笑容**
  - **給自己一個獎勵**
  - 散佈一些**善良**與**寬容**

心理健康及幸福感之建構

- 「心理健康城市」指標架構
  - 建構基礎：**墨爾本憲章**、**WHO於2005年提出之心理健康促進架構**
  - **參考國內外指標**：OECD美好生活指數、主計處國民幸福指數、精神健康基金會之國民精神健康指數、天下雜誌等幸福城市調查、衛生署提出健康城市、安全城市、高齡友善城市等
  - 指標面向：涵蓋**尊重與包容**、**支持支援系統之可及可近性**、**脆弱性**、**經濟社會安全**、**生活型態**、**社會連結**、及**環境**等七大面向



資料來源：張珏(2012)：行政院衛生署「心理健康城市聯盟芻議研討會」成果報告

泰國精神幸福指數(Thai Mental Happiness Index 15 items)



- **測量時機：**
  - 民眾上個月之生命經驗
- **評分標準：**
  - 從來沒有/很少/經常/總是，計四等級
- **題數及面向：**
  - 共計15個問題
  - 區分為**精神狀態**(mental state)、**心理承受能力**(mental capacity)、**心理素質**(mental quality)、及**社會支持**(social support)四大面向

資料來源：Yiengprugsawan, V., Somboonsook, B., Seubsman, S. A., & Sleigh, A. C. (2012). Happiness, mental health, and socio-demographic associations among a national cohort of Thai adults. Journal of happiness studies, 13(6), 1019-1029.

- 以「幸福感」及「SMILE」 為心理健康之宣言及標語



- 發展「SMILE」之相關策略並具體落實
  - 建議應**以「SMILE概念」、「各類場域」、「渥太華宣言」之三維架構**，建構「SMILE」之相關策略
  - **針對不同的目標人口群發掘其重要之心理健康議題**，進而發展心理健康方案，且透過**多元化的教育宣導**
    - 藉由藝人及媒體等渲染力教導民眾提升快樂力的方法
    - 透過小品文競賽等活動提升號召力
    - 採用微電影或音樂錄影帶（MV）等方式，拍攝每個城市的幸福角落與畫面，捕捉不同人生階段的SMILE及快樂
    - 結合廣告公司，透過舉辦記者會、網路平台（youtube、facebook）等媒介，使心理健康可快速觸動民眾引起共鳴
    - 建構心理健康促進之主題及方案時，可延續心理健康月(9月10日至10月10日)之基礎發展，並會同各縣市衛生局共同回應以推動長遠規劃

社區化照護為未來發展趨勢

- 社區式照護系統的主要工作(WHO, 2001)
  - **正確診斷及早期介入**
  - 提供**持續性照護**：精神疾病屬慢性病，所需的服務會因時間而變化
  - **擴大服務範圍**：包括疾病治療及後續回歸社區等服務
  - **與病人及家屬成夥伴關係**：病人與家屬共同參與治療
  - **當地社區的參與**：加強社區教育與有效的整體社區資源
  - **結合基層醫療機構**：基層照護人員需有足夠的專業能力，早期偵測出可能的危險族群與提供持續性照顧
  - **整合性照護**：除藥物治療，還需心理與精神社會復能

參考資料：The world health report 2001: Mental Health: New Understanding, New Hope. (WHO, 2001)

公共衛生：預防重於治療

從「下游救人」走向「上游減少風險」——把資源前移

心理健康城市可以做什麼？韌性個人？韌性家庭？韌性社區？韌性職場？韌性學校？韌性醫療？韌性長照？

核心比喻：與其在下游救人，不如在上游立牌子——「有漩渦，勿下水」

① 健康促進

增進健康
健康生活型態
健康教育

② 初級預防

避免暴露
疫苗接種
環境與職場安全

③ 次級預防

早期發現
篩檢與檢查
高風險監測

④ 三級預防

降低傷害
及時治療
避免併發症

⑤ 復健 / 長照

恢復功能
社會支持
維持生活品質

上游：預防與風險管理

- 事前辨識危險因子
- 降低疾病與傷害發生率
- 讓更多人免於進入「需要救援」的情境

下游：治療與救援

- 事件發生後才介入
- 需要較多醫療與救援資源
- 可能伴隨住院、失能與長期照護需求

公共衛生的價值：把資源往源頭移，降低風險、減少傷害、促進健康與社會永續。

心理健康照護應涵蓋全體民眾

- 初級預防
  - **普及性(universal)預防**：針對健康人口群，以全體民眾為目標
  - **選擇性(selective) 預防**：針對特定對象或族群，以生理、心理及社會因素探討，其罹患精神疾病之風險較高者
  - **指標性(indicated)預防**：針對高風險且具初期症狀者，其被檢驗出有輕微之精神疾病症狀，或以生物標記發現其具備精神疾病之傾向，但卻不符合診斷標準者
- 次段預防
  - 次段預防之目的為透過早期診斷及治療，以降低全體人口中精神疾病罹患率
  - 針對已診斷有精神疾病者
- 末段預防
  - 末段預防之目的為限制殘障、恢復功能，並預防精神疾病之復發（回到社區、職場、學校、社群）
  - 針對慢性精神疾病者

參考資料: Prevention of Mental Disorders: effective, interventions and policy options. (WHO, 2004)

強化心理健康之預防策略與介入方案(WHO，2005)

目標人口群	場域					
	住家	社區	學校	職場	娛樂場所	健康照護
普及性預防 健康人口群	居家環境改善	暴力預防- 社區治安行動 社區照護 整合性鄉村發展	生態改變之支持 兒童友善校園	壓力預防	-	-
	兒童：家訪、技能建立、兒童及青少年發展、學前心理社會因素介入、弱勢族群之營養及心理社會因素介入 婦女：改善教育之可取得性、儲蓄計畫 老年人：協助行動、社區及日間照顧					
選擇性預防 身心障礙者 新住民(含外籍配偶) 家庭照顧者 長照需求家庭	災難發生後心理及社會因素介入之強化、居家環境改善、暴力預防-社區治安行動、社區護理、整合性鄉村發展、生態改變之支持、兒童友善校園、壓力預防					
指標性預防 物質濫用者 家暴受害及加害者 性侵受害及加害者 其他弱勢族群						

重點由「次段與三段預防」轉變為「初段預防」

正向思考
正念
暖色系
關懷
友善
參加活動
運動
有為老化

免於隔離與暴力
社會接納
經濟參與

資料來源： Promoting Mental Health: concepts, emerging evidence, practices. (WHO, 2005)

目標1　使心理健康促進達到全面性覆蓋 1/6

- 心理健康促進之對象應涵蓋全體民眾，議題設定應回歸本質問題，並考量性別、年齡、種族、場域、地域別等因素
  - 心理健康促進應自孕產期即開始養成
    - 培育身心健康發展之環境：
      - 含健康照顧系統、心理照顧系統、社會支持系統、教育與訓練系統、危害環境偵測等五系統
    - 發展完整的心理能力：
      - 「知覺統整」：感官注意與經驗記憶
      - 「情緒監控」：覺察與控制
      - 「行為規劃」：計劃執行與道德約束
      - 「認知功能」：理性思考與判斷選擇
      - 「自我關係」：自我接受與認同
      - 「人際關係」：溝通與互動
    - 養成良好之健康行為與習慣：
      - 含飲食、睡眠、學習、運動、休閒五面向
  - 家庭關係應自婚前即開始提供相關教育
  - 為人父母之角色應自孕前即開始培養

目標1　使心理健康促進達到全面性覆蓋 2/6

年齡	重要議題	場域	相關部門	教材或方式
孕產期	親和性產檢醫療系統 無害性環境 孕產期身心理調適	家庭 社區 職場 醫療機構	內政部、教育部、 勞工局、原委會、 健康局、醫事處、 健保局、國防部、 交通部、勞委會、 原民會	1. 健康孕產環境之篩檢 2. 健康孕產醫療條件 3. 孕產期健康的身心靈平衡（含飲食、睡眠、情緒、0歲教育） 4. 紓壓、深呼吸放鬆之因應技巧 5. 結合孕婦產前檢查服務，進行孕產婦身心檢查，並於檢第8次至第10次（即第38-40週）時，提供認識產後憂鬱症及防治衛教資訊及心理衛生資源，並提供孕婦健康手冊
0-1 (嬰兒期)	生存滿足 完整睡眠與休息生活形態 知覺統整(感官注意與經驗記憶) 健康人際依附	家庭 他人家庭 社區 醫療機構	內政部 （褓姆、托兒所） 健康局、健保局	1. 親職效能 2. 增進健康身心之照顧關係（上課對象包含褓母、托兒所人員) 3. 社區關懷（上課對象包含社區領袖、托兒所人員） 4. 結合兒童預防保健服務，進行兒童發展評估，並提供兒童健康手冊。
2-3 (幼兒期)	親子關係 人我界線 情緒平衡 知覺統整(感官注意與經驗記憶) 自我情緒覺察	家庭 他人家庭 社區 醫療機構	內政部 教育部(尤其社教司) （褓姆、托兒所） 健康局、健保局	1. 存在與分離之教導 2. 自主創造與設限（limit）之平衡 3. 早期教育與遊戲條件 4. 結合兒童預防保健服務，進行兒童發展評估，並提供兒童健康手冊。
4-6 (學齡前兒童期)	親子關係、自我內在對話、 情緒平衡、性別角色、 知覺統整(經驗記憶)、 自我情緒覺察、 行為衝動之自我約束、 認知功能(具體思考)、 自我關係(自我接受)、 人際關係(互動)	家庭 他人家庭 社區 幼稚園 學校 醫療機構	內政部 （褓姆、托兒所） 教育部 健康局、健保局	1. 表達與溝通 2. 情緒管理 3. 性別角色、教育 4. 說故事與正向導引 5. 早期教育與遊戲條件 6. 結合兒童預防保健服務，進行兒童發展評估，並提供兒童健康手冊。

目標1　使心理健康促進達到全面性覆蓋 3/6

年齡	重要議題	場域	相關部門	教材或方式
6-11 **(學齡兒童期)**	性別議題、教育 情緒監控(覺察與控制)、 行為規劃(計劃執行與道德約束)、 認知功能(理性思考與判斷選擇)、 自我關係(自我接受與認同)、 人際關係(溝通與互動) 人際相處、情緒平衡 生活智能、生命理解 生態關懷	社區 家庭 學校	醫事處 教育部 內政部社會司 內政部兒童局 國民健康局 新聞局 原民會 NCC 文建會	1. 情緒管理（含失落、悲傷處理） 2. 壓力管理 3. 人際關係與溝通藝術 4. 生命與生態教育 5. 正向信念與價值
12-18 **(青少年/青春期)**	性別議題、教育 人際相處、情緒平衡 生活智能、自我（self）概念 完整人格建立、生涯規劃 情感關係、家庭關係 社會關懷	社區 家庭 學校 社群	醫事處 教育部 內政部社會司 內政部兒童局 國民健康局 新聞局 原民會 NCC 文建會 勞委會	1. 兩性互動與情感關係處理 2. 自我了解與生涯規劃 3. 壓力因應與自我療癒的方法 4. 原生家庭影響之探索與因應 5. 健康自我效能 6. 生活、養育與法治之知能與技能 7. 生命意義與社會關懷 8. 職場訓練 9. 心理衛生及疾病相關知識 10. 生命創傷覺察與轉化
19-30 **(成年早期)**	生涯規劃、情感關係、 家庭關係、孕婦、 父母角色、新手父母、 職場關係	社區 家庭 學校 社群 職場	醫事處 教育部 國民健康局 內政部社會司 國防部 NCC 新聞局 原民會 文建會 勞委會	1. 職場壓力管理 2. 親職教育 3. 夫妻、家庭經營-與愛共舞 4. 心理問題知能(憂鬱症、自殺、物質濫用等) 5. 危機處理與生活資源 6. 哀傷輔導 7. 健康之女性身心 8. 孕產和親職調適與因應 9. 孕婦健康行為與習慣 10. 生命創傷覺察與轉化

目標1　使心理健康促進達到全面性覆蓋 4/6

年齡	重要議題	場域	相關部門	教材或方式
31-50 (成年中期)	家庭關係、孕婦、 父母角色、新手父母、 職場關係、自我實現、 失業、經濟、責任承擔 婚姻危機（第三者、離婚、分居等）、喪親	社區、家庭、學校、 社群、職場、 民間機構團體	醫事處、教育部、 國民健康局、 內政部社會司、 國防部、NCC、 新聞局、原民會、 文建會、勞委會	1. 生命與生態探索：身心靈合一之療癒（核心轉化、呼吸、運動等多元方式） 2. 危機處理 3. 安適之管理 4. 哀傷輔導
52-64 (成年晚期)	身體調適(更年期心理調適)、 親職轉換(空巢期心理調適)、 生涯轉換(退休心理調適)	社區、家庭、學校、 社群、職場、 民間機構團體	醫事處、教育部、 國民健康局、 內政部社會司、 國防部、NCC、 新聞局、原民會、 文建會、勞委會	1. 挑戰停滯 2. 建立生命轉換之價值觀與能力 3. 規劃新生涯學習、 4. 建立良好運動和休閒習慣 5. 主動開展社區關係 6. 生命意義與價值之覺知與接納
65-74 (初老期)	生活習慣調適、 挑戰慢性疾病、 健康自我管理、 新學習規劃、 人際投入 智慧的傳承、生命的關懷	社區、家庭、學校、 醫療單位、長照單位、 安養機構、 身障福利機構、社群、 社區學園、 民間機構團體	醫事處、教育部、 國民健康局、 內政部社會司、 退輔會、NCC、 新聞局、原民會、 文建會、勞委會	1. 自我照顧 2. 生命回顧與自我了悟 3. 臨終關懷、安寧療護 4. 哀傷輔導 5. 建立健康生活習慣挑戰慢性疾病、規劃新生涯學習、 6. 主動開展社區關係 7. 5.生命合一與靈性追尋之療癒

目標1　使心理健康促進達到全面性覆蓋 5/6

年齡	重要議題	場域	相關部門	教材或方式
75-84 (中老期)	疾病適應、 生活調適、 良好之健康依附習慣、 主動性與時間管理 智慧的傳承、 生命的關懷	社區、家庭、學校、 醫療單位、長照單位、 安養機構、 身障福利機構、社群、 民間機構團體	衛生署醫事處、 國民健康局、 內政部社會司、 退輔會、NCC、 原民會、勞委會、 文建會、教育部	1. 建立良好之健康依附習慣和資源管道 2. 以創意維持良好運動和休閒習慣建立高齡長輩之多元人際支援系統 3. 生命合一與靈性追尋之療癒
85-94 (老老期)	死亡、 尊嚴與價值 良好之健康依附習慣、 智慧的傳承、 生命的關懷	社區、家庭、學校、 醫療單位、長照單位、 安養機構、 身障福利機構、社群、 民間機構團體	衛生署醫事處、 國民健康局、 內政部社會司、 退輔會、NCC、 原民會、勞委會、 文建會、教育部	1. 維持良好之健康依附習慣和資源管道以意志維持良好運動和休閒習慣 2. 生命合一與靈性追尋之療癒
95歲以上 (極老期)	生活照顧、健康照護、 建構支援系統、	社區、家庭、學校、 醫療單位、長照單位、 社群、NGO組織	衛生署醫事處、 國民健康局、 內政部社會司、 退輔會、NCC、 原民會、勞委會、 文建會、教育部	1. 1.老人互相照護 2. 2.如何陪伴家中老人 3. 3.臨終照護 4. 生命合一與靈性追尋之療癒